

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5093723-76.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: DANIELA REGINA DA SILVA

MEDIDA DE URGÊNCIA. ENCAMINHAMENTO À CONSULTA ONCOLÓGICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA VINDICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. LIMINAR RATIFICADA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, de modo a ratificar a decisão anteriormente proferida, nos termos deste voto. Sem condenação em honorários, considerando a natureza do presente processo. Publique-se e intimem-se. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e archive-se o presente processo, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 04 de fevereiro de 2025.

5093723-76.2024.4.02.5101

510015303598 .V7

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5093723-76.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: DANIELA REGINA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta pela UNIÃO FEDERAL em face da decisão que deferiu, em parte, a tutela de urgência, nos autos originários, determinando imediato encaminhamento da parte autora à “consulta ambulatorio 1ª vez - Coloproctologia (Oncologia), com o subsequente tratamento oncológico adequado”.

A decisão (Evento 03) indeferiu a liminar.

É o relatório.

VOTO

No caso, não houve modificação do contexto fático-probatório capaz de alterar o entendimento proferido na decisão, a qual passa a integrar o presente voto:

"DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de medida de urgência interposta em face da decisão, verbis:

*"Trata-se de ação proposta por **Daniela Regina da Silva**, em face da **União**, do **Estado do Rio de Janeiro** e do **Município do Rio de Janeiro**, com pedido de concessão da tutela provisória de urgência, objetivando que os réus providenciem consulta em oncologia - Coloproctologia, bem como o tratamento oncológico adequado para o tratamento da doença que a acomete.*

*Breve relatório. **Decido.***

O juiz poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida na petição inicial quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante o disposto no art. 300 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que é dever do Estado garantir, mediante a implantação de políticas sociais e econômicas, o acesso universal e igualitário à saúde, bem como os serviços e medidas necessários à sua promoção, proteção e recuperação, conforme artigo 196 da CF.

É cediço que o Pretório Excelso já corroborou a intangibilidade do direito fundamental à saúde, legitimando a atuação do Poder Judiciário nesta seara, consoante ementa de acórdão que segue:

E M E N T A: AMPLIAÇÃO E MELHORIA NO ATENDIMENTO DE GESTANTES EM MATERNIDADES ESTADUAIS - DEVER ESTATAL DE ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL RESULTANTE DE NORMA CONSTITUCIONAL - OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO, INCLUSIVE AOS ESTADOS-MEMBROS - CONFIGURAÇÃO, NO CASO, DE TÍPICA HIPÓTESE DE OMISSÃO INCONSTITUCIONAL IMPUTÁVEL AO ESTADO-MEMBRO - DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO PROVOCADO POR INÉRCIA ESTATAL (RTJ 183/818-819) - COMPORTAMENTO QUE TRANSGRIDE A AUTORIDADE DA LEI FUNDAMENTAL DA REPÚBLICA (RTJ 185/794-796) - A QUESTÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL: RECONHECIMENTO DE SUA INAPLICABILIDADE, SEMPRE QUE A INVOCÇÃO DESSA CLÁUSULA PUDE PROMETER O NÚCLEO BÁSICO QUE QUALIFICA O MÍNIMO EXISTENCIAL (RTJ 200/191-197) - O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS INSTITUÍDAS PELA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO - A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO ESTADO - A TEORIA DA "RESTRICÇÃO DAS RESTRICÇÕES" (OU DA "LIMITAÇÃO DAS LIMITAÇÕES") - CARÁTER COGENTE E VINCULANTE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS, INCLUSIVE DAQUELAS DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, QUE VEICULAM DIRETRIZES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ESPECIALMENTE NA ÁREA DA SAÚDE (CF, ARTS. 196, 197 E 227) - A QUESTÃO DAS "ESCOLHAS TRÁGICAS" - A COLMATAÇÃO DE OMISSÕES INCONSTITUCIONAIS COMO NECESSIDADE INSTITUCIONAL FUNDADA EM COMPORTAMENTO AFIRMATIVO DOS JUÍZES E TRIBUNAIS E DE QUE RESULTA UMA POSITIVA CRIAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO DIREITO - CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGITIMIDADE DA OMISSÃO DO ESTADO: ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE CERTOS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS (PROIBIÇÃO DE RETROCESSO SOCIAL, PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL, VEDAÇÃO DA PROTEÇÃO INSUFICIENTE E PROIBIÇÃO DE EXCESSO) - DOUTRINA - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DELINEADAS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (RTJ 174/687 - RTJ 175/1212-1213 - RTJ 199/1219-1220) - POSSIBILIDADE JURÍDICO-PROCESSUAL DE UTILIZAÇÃO DAS "ASTREINTES" (CPC, ART. 461, § 5º) COMO MEIO COERCITIVO INDIRETO - EXISTÊNCIA, NO CASO EM EXAME, DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA: INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO À PROTEÇÃO JURISDICIONAL DE DIREITOS REVESTIDOS DE METAINDIVIDUALIDADE - LEGITIMAÇÃO ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CF, ART. 129, III) - A FUNÇÃO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO "DEFENSOR DO POVO" (CF, ART. 129, II) - DOUTRINA - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

(RE 581352 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 21-11-2013 PUBLIC 22-11-2013)

A Lei nº 12.732/2012, que dispõe sobre primeiro tratamento de paciente com neoplasia maligna, assim estabeleceu:

Art. 1º O paciente com neoplasia maligna receberá, gratuitamente, no Sistema Único de Saúde (SUS), todos os tratamentos necessários, na forma desta Lei.

Parágrafo único. A padronização de terapias do câncer, cirúrgicas e clínicas, deverá ser revista e republicada, e atualizada sempre que se fizer necessário, para se adequar ao conhecimento científico e à disponibilidade de novos tratamentos comprovados.

Art. 2º O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único.

§ 1º Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso.

§ 2º Os pacientes acometidos por manifestações dolorosas consequentes de neoplasia maligna terão tratamento privilegiado e gratuito, quanto ao acesso às prescrições e dispensação de analgésicos opiáceos ou correlatos.

Art. 3º O descumprimento desta Lei sujeitará os gestores direta e indiretamente responsáveis às penalidades administrativas.

Art. 4º Os Estados que apresentarem grandes espaços territoriais sem serviços especializados em oncologia deverão produzir planos regionais de instalação deles, para superar essa situação.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor após decorridos 180 (cento e oitenta) dias de sua publicação oficial.

No caso dos autos, os documentos médicos acostados comprovam que a autora foi diagnosticada com neoplasia maligna do cólon apresentando adenocarcinoma invasivo em exame Histopatológico, com resultado em 06/08/2024, sendo encaminhada à consulta oncológica Ambulatório 1ª vez - Coloproctologia (Oncologia) e inserida no Sistema Estadual de Regulação - SER em 07/08/2024. (Anexo 2 do Evento 1).

De acordo com o Parecer da Câmara de Resolução de Litígios, a autora foi regulada para consulta em Ambulatório 1ª vez - Coloproctologia (Oncologia), inserida em 07/08/2024, apresenta situação - em fila, com tempo estimado de espera de 105 dias (Anexo 2 do Evento 1).

A certidão do Evento 2, por sua vez, confirma a situação supracitada: "Paciente inserida no SER em 07/08/2024 para o recurso Ambulatório 1ª vez - Coloproctologia (Oncologia). Em fila, aguardando disponibilidade de vaga por prestador habilitado."

Dessa forma, diante do disposto nos documentos médicos que acompanham a inicial, da ausência de resolução administrativa e da urgência que decorre da própria doença apresentada pela autora (neoplasia maligna) e expressa no documento que acompanha a inicial, entendo presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência ora vindicada.

Assim, **defiro a antecipação dos efeitos da tutela**, com fulcro no art. 4º, da Lei nº 10.259/01, c/c art. 300, do Código de Processo Civil, e **determino** que os réus providenciem imediatamente à parte autora consulta ambulatório 1ª vez - Coloproctologia (Oncologia), com o subsequente tratamento oncológico adequado.

Considerando o Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre a Justiça Federal de 1º Grau do Rio de Janeiro e a Secretaria de Estado de Saúde, **intime-se o NAT - Núcleo de Assessoria Técnica em Ações de Saúde -, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente parecer técnico com os esclarecimentos que entender necessários sobre a possibilidade de fornecimento do tratamento pelo SUS, no caso narrado na inicial, ou então alternativa terapêutica fornecida pelo poder público.**

Citem-se os réus para apresentação de contestação, no prazo legal, contado em dias úteis, instruindo a peça com os documentos necessários ao deslinde do feito e prestando as informações acerca dos insumos objetos da lide.

Suspenda-se o curso do processo até apresentação da resposta ou decurso do prazo, o que ocorrer primeiro, por se tratar de prazo superior a 30 (trinta) dias corridos.

Intimem-se os demandados desta decisão.

Intime-se, com urgência, para cumprimento por mandado, a Central de Regulação de Vagas - Complexo Regulador Estadual - Coordenação da Assessoria Jurídica no endereço: Rua Barão de Itapagipe, 225, Bloco -B, 2º Andar, Rio Comprido, Rio de Janeiro, CEP 20261-005. Telefone: (21) 3385-9222, por mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça para, mediante inserção no Sistema Estadual de Regulação - SER, comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, o cumprimento da tutela deferida.

Intime-se a DPU.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça."

É o breve relatório.

Sabe-se que são requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência: a) a probabilidade do direito pleiteado, ou seja, uma plausibilidade lógica que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, do que decorre um provável reconhecimento do direito, baseada em uma cognição sumária; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso não concedida, ou seja, quando houver uma situação de urgência em que se não se justifique aguardar o desenvolvimento natural do processo sob pena de ineficácia ou inutilidade do provimento final.

A parte autora comprovou os requisitos.

A parte autora comprovou ser portadora de câncer de colo sigmoide, por meio da juntada de documentos proferidos por médico da rede pública de saúde. (processo 5087576-34.2024.4.02.5101/RJ, evento 1, ANEXO2)

O NAT juntou parecer no evento processo 5087576-34.2024.4.02.5101/RJ, evento 26, PARECER1 afirmando que a consulta médica está indicada para o caso clínico da parte autora.

Rio de Janeiro, 11 de novembro de 2024.

Processo nº 5087576-34.2024.4.02.5101,
ajuizado por **Daniela Regina da Silva**.

Trata-se de Autora, 46 anos de idade, com diagnóstico de **câncer de cólon sigmoide**, submetida à sigmoidectomia (Evento 1, ANEXO2, Páginas 9 a 16), solicitando o fornecimento de **consulta em oncologia (Coloproctologia)** (Evento 1, INIC1, Página 10).

De acordo com as Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do Câncer de Cólon e Reto, aprovadas pela Portaria nº 958, de 26 de setembro de 2014¹, o tratamento padrão para o câncer do reto é a ressecção cirúrgica do tumor primário. A quimioterapia adjuvante está indicada para doentes com câncer colorretal no estágio III e, excepcionalmente, no estágio II, a critério médico. A quimioterapia prévia (pré-operatória) está indicada para doentes com câncer de reto no estágio II ou III, associada à radioterapia. A decisão quanto à indicação da radioterapia adjuvante para doentes com câncer de reto no estágio I deve considerar a extensão da neoplasia e o grau de diferenciação histológica do tumor. Doentes com diagnóstico de câncer colorretal devem ser atendidos em hospitais habilitados em oncologia e com porte tecnológico suficiente para diagnosticar, tratar e realizar o seu acompanhamento.

Desta forma, informa-se que a **consulta em oncologia (Coloproctologia) está indicada** ao manejo da condição clínica da Autora - **câncer de cólon sigmoide, submetida à sigmoidectomia** (Evento 1, ANEXO2, Páginas 9 a 16). Além disso, **está coberta pelo SUS**, conforme a Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses/Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde - SUS (SIGTAP), na qual consta: **consulta médica em atenção especializada**, sob o seguinte código de procedimento: 03.01.01.007-2, considerando o disposto na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES).

No que tange ao acesso no SUS, a Atenção Oncológica foi reestruturada em consonância com a Rede de Atenção à Saúde e de forma articulada entre os **três níveis de gestão**.

O Componente de Atenção Especializada é composto por ambulatorios de especialidades, **hospitais gerais e hospitais especializados habilitados** para a assistência oncológica. Esses devem apoiar e complementar os serviços da atenção básica na investigação diagnóstica, no tratamento do câncer (...), garantindo-se, dessa forma, **a integralidade do cuidado no âmbito da rede de atenção à saúde**. O componente da Atenção Especializada é constituído pela Atenção Ambulatorial e Hospitalar.

A Atenção Hospitalar é composta por hospitais habilitados como **UNACON** (Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) e **CACON** (Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) e por Hospitais Gerais com Cirurgia Oncológica, nos quais são oferecidos os tratamentos especializados de alta complexidade, incluindo serviços de cirurgia, radioterapia, quimioterapia, e cuidados paliativos, em nível ambulatorial e de internação, a

dependem do serviço e da necessidade identificada em cada caso. Sempre com base nos protocolos clínicos e nas diretrizes terapêuticas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, quando publicados.

Em consonância com o regulamento do SUS, conforme pactuação na Comissão Intergestores Bipartite (**Deliberação CIB-RJ nº 4.004 de 30 de março de 2017**), o Estado do Rio de Janeiro conta com uma **Rede de Alta Complexidade Oncológica (ANEXO I)**².

O ingresso dos usuários nas unidades que ofertam os serviços do SUS, ocorre por meio do sistema de regulação, conforme previsto na Política Nacional de Regulação que organiza o serviço em três dimensões (Regulação de Sistemas de Saúde, Regulação da Atenção à Saúde e Regulação do Acesso à Assistência) para qualificar a atenção e o acesso da população às ações e aos serviços de saúde³.

Em consulta à plataforma do Sistema Estadual de Regulação – SER (ANEXO II), foi localizado para a Autora solicitação de **Consulta - Ambulatório 1ª vez - Coloproctologia (Oncologia)**, CID: **Neoplasia maligna do cólon**, solicitado em: 07/08/2024, pelo Centro Municipal de Saúde Pedro Nava, classificação de risco: **Verde – prioridade 3**, com situação: **Em fila**, posição: **135º**.

Assim, informa-se que a **via administrativa para o caso em tela já está sendo utilizada**. Contudo, **ainda sem a resolução da demanda**.

É o Parecer

À 34ª Vara Federal do Rio de Janeiro, da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, para conhecer e tomar as providências que entender cabíveis.

Nos termos do parecer do NAT, foi informado que a parte autora está com solicitação de consulta, para neoplasia maligna do cólon com situação em fila: posição 135.

Todavia, a parte autora já possui o diagnóstico de portadora de neoplasia maligna desde 15/07/2024. (processo 5087576-34.2024.4.02.5101/RJ, evento 1, ANEXO2).

Sr(a): DANIELA REGINA DA SILVA
RA: 0660224548 - Idade: 46 ANOS
RG: 0
Cód. apolo: P-1691839
Dr(a): DANTE ASSED SILVA/01201344
Coleta: HOSPITAL ROCHA FARIA - Entrega: SALA AMARELA FEMININA CIRURGIA GERAL
Convênio: HOSPITAL ROCHA FARIA
Dt Coleta: 15/07/2024 - 00:00:00 - Saída: 06/08/2024 - 08:01:05

CONCLUSÃO:
DIAGNÓSTICO:
- ADENOCARCINOMA INVASIVO (WHO, 2010*) COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:
Medidas: 5,1 x 3,8 x 2,1 cm
Grau Histológico: GRAU 1
Profundidade de Invasão: TECIDO ADIPOSE
Invasão Linfo-vascular: PRESENTE
Invasão perineural: NAO DETECTADA
Infiltrado inflamatório peritumoral: LEVE
Infiltrado inflamatório Intratumoral: LEVE
Subtipo e/ou Desdiferenciação: NAO DETECTADO
Depósitos tumorais: NAO DETECTADO
Tumor Budding: NAO DETECTADO
Margem cirúrgica proximal: LIVRE DE NEOPLASIA
Margem cirúrgica distal: LIVRE DE NEOPLASIA
Margem cirúrgica circunferencial/radial: EXÍGUA A NEOPLASIA
Estadiamento Anatomopatológico baseado nestes espécimes cirúrgicos (pTNM, AJCC 8th Edition): pT3, pN1b, pMx
Nota(s):
- Necessário estudo imuno-histoquímico para pesquisa das proteínas dos genes de reparo do DNA (MSH6, MLH1, MSH2 e PMS2).
- Recomendamos estudos moleculares complementares para pesquisa de K-ras, N-ras e BRAF para fins prognósticos/terapêuticos.
Obs: Laudo em conformidade com as diretrizes do Colégio Americano de Patologia.
*Bosman FT, Carneiro F, Hruban RH, Theise ND, eds. WHO Classification of Tumours of the Digestive System. Geneva, Switzerland: WHO Press; 2010.
Laudo finalizado por: Dra. Lígia Vara Artigiani CRM-SP:150248 RQE:68854
Laudo liberado por: Dra. Lígia Vara Artigiani CRM-SP:150248 RQE:68854
Método: MICROSCOPIA ÓPTICA

Método: COLORAÇÃO E MICROSCOPIA

Liberado por: DIAGNOSTICO BRASIL - * 0

06/08/2024 08:02:

Dispõe o art. 2º da Lei 12.732/2012 que "O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no **prazo de até 60 (sessenta) dias** contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico **ou em prazo menor**, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único".

Com efeito, o prazo máximo de 60 dias previsto para início do tratamento oncológico no artigo 2º da Lei nº 12.732/12 pode, ainda, ser reduzido em caso de necessidade terapêutica registrada em prontuário.

De tal sorte, observa-se que prazo legal não foi obedecido.

Assim, enquanto a parte autora aguarda o devido tratamento para a sua enfermidade, o tempo decorrido acarreta agravamento do quadro clínico e aumento da possibilidade de evolução para óbito.

Presentes, portanto, o periculum in mora e o fummus boni juris.

Quanto à argumentação sobre a necessidade de observância de critérios isonômicos na organização da fila de espera pela Administração, o princípio da impessoalidade, garantidor da isonomia alvejada nas respostas institucionais às demandas trazidas pela população, não pode servir de justificativa para relativizarem-se peculiaridades individuais no importe de sofrimento desproporcionalmente majorado ou de normalização da precariedade/morosidade na prestação dos serviços públicos.

No que toca à irreversibilidade dos efeitos de uma possível decisão satisfativa tomada neste momento, calha ressaltar que a não concessão da tutela antecipada teria efeitos muito mais graves, deletérios e permanentes do que a eventual despesa financeira que o Poder Público possa ter.

Quanto ao tema, cabe mencionar o enunciado 40 da I Jornada de Direito Processual Civil, que assim dispõe: "**ENUNCIADO 40** - A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível."

Portanto, afigura-se mais adequado para solucionar o conflito entre o direito à saúde e a capacidade orçamentária do Poder Público, que a transferência hospitalar seja realizada.

Presentes, portanto, os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela.

O Tema 793, estabeleceu que "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (RE 855178, em 23.05.2019).

Na mesma direção, os enunciados 8, 60, 87 CNJ trataram, respectivamente, do respeito à repartição de competências entre os entes, da necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação a um dos entes e da individualização da atribuição dos entes.

No caso, a lei assegura o atendimento através das Unidades credenciadas como UNACON/CACON, sendo correto o entendimento de que os réus, solidariamente, deverão informar qual a unidade credenciada da rede pública com disponibilidade para realizar a primeira consulta.

Do exposto, voto por indeferir o requerimento de natureza cautelar de atribuição de efeito suspensivo.

Após, à conclusão para voto.

Publique-se. Intime-se."

Por todo o exposto, voto por **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO**, de modo a ratificar a decisão anteriormente proferida, nos termos deste voto. Sem condenação em honorários, considerando a natureza do presente processo. Publique-se e intime-se. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquite-se o presente processo.